Autos: 0801065-41.2021.8.12.0037
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Requerente:Alcides Barbosa da Silva
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

ALCIDES BARBOSA DA SILVA, qualificado, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Requerimento de Tutela de Urgência em face do **MUNICÍPIO DE DOURADINA/MS e do ESTADO DE MATO GROSSO DO SU**L, igualmente qualificados. Arguiu, em síntese, que é portador de arritmia cardíaca (CID10 l49.9) e insuficiência renal (CID10 N19), sendo necessário para o seu tratamento, com urgência, a utilização do medicamento ELIQUIS 2.5mg, porém, não possui condições financeiras para arcar com o custo do tratamento, que importa no valor de R$ 3.038,40 (três mil e trinta e oito reais e quarenta centavos), correspondente ao período de 12 (doze) meses. Alegou que foram encaminhados ofícios aos requeridos (n.º 66/2021 e n. 67/2021), mas não obteve resposta. Afirmou que a não utilização do medicamento pode agravar o seu problema, acarretando danos irreversíveis à sua saúde. Pleiteou a concessão de tutela de urgência, a fim de garantir a sua saúde, e, ao final, a procedência do pedido. Anexou à inicial os documentos de fls. 12-25.

Encaminhado os autos ao NAT, o Núcleo foi desfavorável ao pedido (fls. 27-35).

Decisão interlocutória concedendo a liminar pleiteada (fls. 36-41).

Citado (fl. 51), o município de Douradina/MS não apresentou contestação no prazo legal (fl. 85).

Em contestação, o Estado do Mato Grosso do Sul alegou, preliminarmente, a competência da União para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e a necessidade de sua inclusão no polo passivo, com consequente remessa do feito a Justiça Federal. No mérito, alega que autora pleiteia o fornecimento pelo Estado do medicamento Apixabana, não incorporado ao SUS. Logo, é o caso de aplicação do entendimento do STJ no julgamento do RE nº 1.657/RJ (tema 106). Dito isso, alega que a autora não comprovou os requisitos fixados pelo STJ no tema 106. Outrossim, aduz que a CONITEC já promoveu a análise para incorporação do(s) medicamento(s) Apixabana por meio do Relatório de Recomendação nº 195 - Apixabana, Rivaroxabana e Dabigatrana em paciente com fibrilação atrial não valvar (CONITEC, fevereiro/2016), tendo deliberado, por unanimidade de seus membros, por recomendar a sua não incorporação. Como justificativa, os técnicos da CONITEC expuseram, com base na análise de evidências científicas de alta qualidade, que as evidências científicas dos medicamentos analisados demonstram que não há superioridade dos mesmos em relação ao medicamento Varfarina. Deste modo, invoca que não há justificativa para que se dê preferência ao laudo médico em detrimento da conclusão contrária apresentada pela CONITEC para incorporação do medicamento pleiteado. Por fim, no caso de procedência da demanda, invoca a eventual concessão de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

medicamento genérico e que não haja fixação de multa diária, tal como seja determinada a exclusão de multa eventualmente já fixada, dando-se preferência ao bloqueio de verbas caso haja necessidade de execução forçada do julgado.

A Fazenda Estadual juntou aos autos acordo celebrado com o Município de Douradina/MS para o fornecimento do medicamento pleiteado pela requerente (fls. 71-72).

O Estado do Mato Grosso do Sul comprovou nos autos o depósito de valor para o tratamento da requerente pelo prazo de 06 meses (fl. 76-78).

Alvará indicando a transferência do numerário para o estabelecimento farmacêutico que apresentou o menor preço (fl. 84).

A autora juntou aos autos a nota fiscal (fl. 93-94).

O Estado do MS não se opôs as contas apresentadas pela requerente (fl. 98).

Ofício juntado ao feito, informando que o Estado do Mato Grosso do Sul interpôs agravo de instrumento em face da decisão de fls. 36-41 proferida por este juízo. No ofício, consta na ata que a decisão foi a seguinte: *Por unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Divergiu o 1º vogal para acolher o pedido preliminar de inclusão da união no polo passivo (fls. 99-135).*

A autora requereu o julgamento antecipado do mérito (fl. 142). Os requeridos, por seu turno, não indicaram as provas que pretendiam produzir (fl. 149).

É o relatório. Decido.

O processo está apto a receber julgamento antecipado, porque presente a hipótese do art. 355, I, do CPC, não havendo necessidade da produção de outras provas.

I – Da preliminar de inclusão na União no polo passivo.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE nº 657718/MG, firmou a tese de que "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União".

Ocorre que, na fatispécie, o medicamento Apixabana (princípio ativo) possuí registro na Anvisa, conforme item IV do Parecer de fls. 27-35.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

Ademais, no mesmo parecer, o NAT informou que o medicamento pleiteado pela requerente não está padronizado na lista do RENAME, circunstâncias que tornam a inclusão da União no polo passivo desnecessária (fls. 27-35).

Com efeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que proveu o Recurso Ordinário para determinar o prosseguimento do writ no Tribunal a quo. O Mandado de Segurança fora impetrado por portadora de doença de Crohn contra ato coator atribuído ao secretário de saúde do Estado de Goiás, consistente no não fornecimento do medicamento budesonida 3mg, com registro na Anvisa, mas não incluído no Rename. 2. ***O STF, no julgamento Tema 793 (relativo à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde), decidiu o RE 855.178/SE, paradigma de repercussão geral, reafirmando a responsabilidade solidária de todos os entes da Federação e concluindo pela legitimidade destes, isolada ou conjuntamente, para comporem o polo passivo de ações que envolvam o fornecimento de medicamentos. 3. Sendo o medicamento pleiteado registrado na Anvisa, deve prevalecer a escolha firmada pelo impetrante no que concerne à indicação do polo passivo do mandamus. A jurisprudência do STJ não exige a inclusão da União no polo passivo nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), mas registrados na Anvisa.*** *4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 68.612/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)*

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO CONSTANTE NA RENAME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 150 E 224/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. I - Trata-se de conflito negativo de conflito negativo de competência

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

instaurado entre o Juízo Federal da 6ª Vara de Joinville - SJ/SC e a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o Estado de Santa Catarina e o Município de Campo Alegre, objetivando o fornecimento de insumos para o tratamento de enfermidade de paciente, em razão de não possuir recursos financeiros para sua aquisição. ***II - No julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.*** *III - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente".* ***IV - Na tese fixada do RE n. 855.178/SE, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso, em ementa, sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. V - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.*** *VI - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: "Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente." e "Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas." VII - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte." VIII - No que tange à alegação de ofensa à Súmula n. 224/STJ, o que se constata é uma enorme judicialização da questão relativa a fornecimento de medicamento ou outros procedimentos inerentes a tratamento de saúde, e quando se instaura um conflito de competência nesse tipo de ação, evidente a situação de maior postergação na elucidação da controvérsia, em claro prejuízo à parte necessitada. IX - Nesse panorama, faz-se necessária uma resposta mais eficaz possível, conforme bem deliberado pelo Ministro Herman Benjamin, em caso análogo: "O Conflito de Competência está caracterizado, porquanto "2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência" (art. 66, II, do CPC), ainda que, eventualmente, com má aplicação do enunciado 224 do STJ por um deles." (AgInt no CC n. 177.800/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2/12/2021.) X - Em outro precedente análogo, foi assim considerado: "Da simples leitura do excerto transcrito, verifica-se que o acórdão embargado, fundamentadamente, negou provimento ao Agravo interno, concluindo pela competência da Justiça estadual, para o processo e julgamento do feito, nos termos das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ, porquanto "o Juízo Federal, em decisão irrecorrida, reconheceu, expressamente, a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva." (EDcl no AgInt no CC n. 178.773/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 16/11/2021.) XI - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no CC n. 182.610/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Neste sentido, rejeito a preliminar suscitada e, por consequência, o deslocamento do feito para a Justiça Federal ante a prescindibilidade de inclusão da União no polo passivo.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao mérito da causa.

II – Do Mérito.

No mérito, entendo que a ação deve ser julgada procedente.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

O acesso à saúde foi elevado à condição de direito fundamental do homem, sendo incontroverso o dever do Poder Público, assim entendidos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, em disponibilizar serviços de saúde pública a todos os cidadãos. Logo, trata-se de responsabilidade solidária.

Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Do mesmo teor a Lei Federal 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde):

Art. 2.º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Art. 4.º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

A matéria, portanto, recebe tratamento de direito inalienável da pessoa humana, pois a Constituição Federal consignou a obrigação de Estado propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, consagrando o Sistema Único de Saúde − SUS como responsável pelas ações e serviços públicos de saúde, composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, e organizado de acordo com a descentralização, prestando serviço de atendimento de forma integral, ou seja, a assistência à saúde deverá seguir as diretrizes estabelecidas constitucionalmente, de forma ampla e universal, sem restrições por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou dificultar o acesso a essa garantia constitucional.

Aliás, saliento que a questão referente à concessão de medicamentos pelo poder público restou decidida em sede de recurso repetitivo, por meio do Resp 1.657.156/RJ, cuja ementa transcrevo abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 ***A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.*** *5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).*

Sobre os autos, colaciono parte do laudo médico do profissional que assiste o autor (fls. 15-17):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

4. Qual é a finalidade? do medicamento prescrito:
( ) Profilática ( ) Curativa ( ) Paliativa ( ) Diagnóstico (X) Outra(s)

Especifique qual(is): diminuição risco de evento trombótico

5. Existem tratamentos oferecidos pelo SUS para a doença citada com a mesma eficácia do tratamento indicado? Se afirmativa a resposta, qual(is)?
não

6. As alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS já foram utilizadas? (X) Sim ( ) Não

Em caso afirmativo:
6.1 Especifique o período de tratamento e a resposta obtida:
varfarina 5mg, porém sem controle do TAP

6.2 O(A) paciente faz uso de outro(s) tratamento(s) (farmacoterapêuticos ou não) para a doença? Qual(is)?
aspirina

7. O tratamento indicado na sua prescrição pode ser substituído por alguma alternativa oferecida pelo SUS?
( ) Sim* - Especifique qual(is): (X) Não
Se negativa a resposta:
7.1 Quais as vantagens do tratamento proposto para o(a) paciente se comparado com eventuais fármacos ou tratamentos oferecidos pelo SUS para a(s) mesma(s) moléstia(s)?
menor risco de sangramento

8. O(s) medicamento(s) é(são) imprecindível(is) para o(a) paciente: (X) Sim ( ) Não
Justifique: pelo alto risco de AVC e outros eventos trombóticos

9. A disponibilização do(s) medicamento(s) é urgente: (X) Sim ( ) Não

10. A não utilização imediata do(s) medicamento(s) poderá ocasionar quais das seguintes consequências?
(X) Risco de Morte
(X) Perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas
( ) Grave comprometimento do bem estar
( ) Outras – Qual(is):
11. Especificar o Quadro Clínico e as Peculiaridades do(a) Paciente e demais considerações finais:
Paciente com alto risco de acidente vascular cerebral recomendo a anticoagulação

Local: Dourados Data: 02/08/21

Pois bem.

No caso *sub judice*, concluo que os requisitos fixados pelo STJ (Resp. 1.657.156-RJ – Inf. 633) encontram-se presentes, uma vez que demonstrada a hipossuficiência financeira da parte autora, eis que assistido pela Defensoria Pública. Ademais, o medicamento encontra-se registrado na Anvisa e não possui registro na lista do RENAME, conforme parecer do NAT de fls. 27-35. Outrossim, o profissional responsável pelo acompanhamento do requerente declarou que **(i) não existem tratamentos oferecidos pelo SUS com a mesma eficácia do tratamento indicado; (ii) que o fármaco apresenta menor risco de sangramento em relação aos medicamentos oferecidos pelo SUS; (iii) que o medicamento é imprescindível, em razão do alto risco de AVC e outros eventos trombóticos; (iv) que a não utilização do medicamento poderá gerar risco de morte e perda irreversível de órgãos e funções orgânicas; e que (v) que as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS já foram utilizadas**

Sobre isso, já se manifestou a jurisprudência:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

APELAÇÃO CÍVEL − AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/TUTELA DE URGÊNCIA − PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO AFASTADA − TEMA 793 DO STF − RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ (TEMA 106) − REQUISITOS PREENCHIDOS − EXIGÊNCIA DE CADASTRO NO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) − FORMALISMO EXAGERADO − PREQUESTIONAMENTO − COM O PARECER MINISTERIAL − RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme Tema n.º 793, do STF, a responsabilidade dos entes federados para o fornecimento de medicamentos é solidária. A inclusão da União no polo passivo somente é obrigatória quando o fármaco pretendido não possuir registro na ANVISA, situação que não se apresenta no caso dos autos. ***Havendo laudo médico pelo profissional que assiste a paciente, afirmando a imprescindibilidade do medicamento, em conjunto com a constatação da sua incapacidade financeira para arcar com o custo do remédio prescrito, bem como a existência de registro na ANVISA, nos termos do Tema n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, o fornecimento do tratamento é a medida que se impõe.*** *Descabida a exigência cadastro da Apelada junto ao Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (PCDT) para fins de registro do uso/retirada dos medicamentos fornecidos pela rede pública, por configurar formalismo exacerbado que não justifica a recusa da disponibilização de medicamentos indispensáveis para o tratamento das moléstias que acometem a paciente, sob pena de afronta ao princípio da eficiência na prestação de serviços públicos. Quanto ao prequestionamento, esta Corte tem entendido ser desnecessária a manifestação expressa dos dispositivos legais utilizados para a conclusão do julgamento, bastando que as matérias postas em discussão tenham sido apreciadas adequadamente. Recurso conhecido e desprovido, com o parecer. (TJMS. Apelação Cível n. 0801606-58.2021.8.12.0010, Fátima do Sul, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Desª Jaceguara Dantas da Silva, j: 08/04/2022, p: 12/04/2022).*

APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Aplicação do RESP 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ). Tese fixada pelo STJ. ***A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento. *Adequação aos requisitos delineados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 106. Reexame necessário e recurso voluntário improvidos. (TJSP; APL-RN 1014552-56.2021.8.26.0053; Ac. 15550241; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Laura Tavares; Julg. 04/04/2022; DJESP 20/04/2022; Pág. 5056).*

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ. TEMA 106 DO STJ. TEMOZOLOMIDA. NEOPLASIA MALIGNA DA MEDULA ESPINHAL. NECESSIDADE COMPROVADA. CONCESSÃO JUDICIAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Conforme a regra da singularidade recursal estabelecida pela nova Lei Adjetiva Civil (art. 496, § 1º), tendo sido interpostas apelações pelos entes federados, a hipótese que se apresenta é de não cabimento da remessa necessária. 2. ***Nos termos definidos no julgamento do RESP nº 1.657.156/RJ (Tema 106 - STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. A indispensabilidade do medicamento vindicado nas demandas alusivas às prestações de saúde deve ser aferida não apenas em razão da comprovada eficácia do fármaco no tratamento de determinada doença, mas, também, da inexistência ou da patente inefetividade das opções terapêuticas viabilizadas pelo SUS.*** *4. In casu, o jurisperito chancelou a prescrição medicamentosa do profissional assistente, assentando a necessidade de utilização do fármaco pela parte autora. 5. Em não havendo situação excepcional a recomendar outro valor, os réus devem ser condenados em honorários advocatícios à razão de R$ 3.000,00 (três mil reais), pro rata. Precedentes desta Turma. (TRF 4ª R.; APL-RN 5003013-45.2021.4.04.7207; SC; Turma Regional Suplementar de SC; Rel. Des. Fed. Celso Kipper; Julg. 08/04/2022; Publ. PJe 18/04/2022).*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

Portanto, considerando que o autor preenche os requisitos elencados pela jurisprudência do colendo STJ para o fornecimento dos medicamentos não incorporados no SUS, a procedência do pedido inicial compelindo os requeridos ao fornecimento do medicamento ELIQUIS 2.5mg é a medida que se impõe.

No que tange à irresignação do Estado do Mato Grosso do Sul quanto a fixação de multa cominatória, explico que a determinação de constrição de recursos orçamentários mostra-se amplamente cabível quando resta manifesta e reiterada a omissão estatal na implementação de políticas públicas de saúde.

No mais, a fixação de multa diária tem a finalidade de garantir a eficácia da determinação judicial, bem como se qualifica como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, conforme preceitua o artigo 497 do CPC.

Sobre a fixação da multa cominatória, já se manifestou o egrégio TJMS em casos similares:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO MIG. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO COM O PARECER. 1. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão que determinou que o ente público forneça o tratamento prescrito por médico responsável para o paciente. 2.* ***Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 98), é perfeitamente admissível o arbitramento de multa sancionatória contra a Fazenda Pública para compelí-la ao cumprimento de obrigação judicial. 3. Recurso não provido.*** *(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407423-50.2022.8.12.0000, Caarapó, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 19/08/2022, p: 23/08/2022).*
>
> *AGRAVO DE INSTRUMENTO − OBRIGAÇÃO DE FAZER − ESTADO E MUNICÍPIO − FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ − PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN − NECESSIDADE E CARÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA − TUTELA DE URGÊNCIA − REQUISITOS PREENCHIDOS − ASTREINTES − ADMITIDA − VALOR RAZOÁVEL − RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a necessidade da fórmula infantil e a carência financeira para adquiri-lo, é dever do ente público o fornecimento, garantindo as condições*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

mínimas de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. Não se permite ao Poder Público omitir-se do dever imposto constitucionalmente, opondo a escusa da limitação orçamentária e da cláusula da reserva do possível, eis que tal resultará na anulação e frustração do direito fundamental à saúde, que se afigura o mínimo existencial. ***É cabível a imposição de multa em face da Fazenda Pública como meio de compelir o devedor a cumprir a obrigação de fornecer o tratamento médico necessário ao combate de moléstia (REsp 1.474.665/RS).*** *(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1404171-73.2021.8.12.0000, Naviraí, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 02/08/2021, p: 06/08/2021).*

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE CONSULTA E CIRURGIA − DIREITO À SAÚDE − DEVER DO ESTADO GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL − RESERVA DO POSSÍVEL − PREVALÊNCIA DO EFETIVO CUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MULTA COMINATÓRIA − MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados-Membros e Municípios, de forma solidária), o qual deverá garantir aos indivíduos a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna. Quando o tratamento é requerido com base em laudo elaborado por profissional médico e o indivíduo não tem condições de arcar com seus custos, consideram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, principalmente considerando que há atendimento na rede pública de saúde para a especialidade pleiteada. ***É permitida multa coercitiva contra a Fazenda Pública, objetivando coagir o ente público a cumprir obrigação que deve ser imediatamente executada, para que a ordem judicial não perca a natureza compulsória.*** *(TJMS. Apelação Cível n. 0804853-58.2018.8.12.0008, Corumbá, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 24/08/2022, p: 29/08/2022).*

Assim, entendo suficiente e compatível com o seu conteúdo a manutenção da fixação de multa diária, posto que não exorbitou o patamar do razoável.

Sobre os honorários advocatícios em face do Ente Estadual, sendo a demanda proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, que é um órgão do próprio Estado, não se afigura factível condená-lo a pagar verbas de sucumbência em favor de seu próprio órgão.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

> *APELAÇÃO − PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - HONORÁRIOS DPE EM FACE DO MUNICÍPIO − CABIMENTO − CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL − RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.* ***1) Sabemos que é plenamente cabível o pagamento de honorários pelo Município à Defensoria Pública vencedora, pois, nesse caso, não há confusão entre credor e devedor, vez que aquele não possui qualquer relação ou vínculo com a Defensoria Pública Estadual com a qual contende nesta lide, sendo pessoas jurídicas de direito público distintas (ao contrário do que ocorre com o ente público estadual, conforme súmula 421 do STJ)****. 2) Tal valor deve ser fixado de acordo com o § 8º c/c § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015. 3) Recurso conhecido e em parte provido, honorários arbitrados por este Colegiado em valor razoável e proporcional à complexidade da demanda. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0813930-78.2019.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 13/12/2020, p: 16/12/2020).*

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421: *Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.*

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 196 e 198, § 1º, da Constituição Federal, confirmo a liminar concedida às fls. 36-41 e julgo **procedente** o pedido inicial, para condenar os réus, solidariamente, a fornecerem o medicamento ELIQUIS 2.5mg para o autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a 15 (quinze) dias, com sequestro dos valores da conta bancária vinculada à propaganda institucional.

Declaro resolvido o mérito da ação, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Atento ao princípio da sucumbência, condeno o município de Douradina/MS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à DPE, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Deverá ser observado pela serventia deste juízo: (a) para a hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §1º); (b) havendo apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.010, §2º); (c) sendo suscitada(s) preliminar(es) nas contrarrazões, intime(m)-se o(s) recorrente(s) para, em 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se (CPC, art. 1.009, §1º).

Atendidas as formalidades acima para a hipótese de interposição de recurso deste *decisum*, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.

com as homenagens de estilo, independentemente de nova conclusão.

Decorrido o prazo do recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para o reexame necessário, considerando que a medicação é de uso contínuo, o que implica em prazo indeterminado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e, após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedidas às necessárias anotações.

Itaporã, 15 de setembro de 2022.

Evandro Endo
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVANDRO ENDO, liberado nos autos em 15/09/2022 às 18:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801065-41.2021.8.12.0037 e código QeyBYrwP.